



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULANAN
INSTALASI RADIOLOGI
BULAN JULI 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



I. SUMBER DAYA MANUSIA:

1.1 Ketenagaan

Tabel 1.1 Pola Ketenagaan Unit

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	JUNI	Kebutuhan	
Ka Instalasi	1	1	0	Telah memenuhi standar
Ka Ruang	1	1	0	Telah memenuhi standar
Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	Telah memenuhi standar
Pelaksana	2 orang/alat	5	0	Belum memenuhi standar

Tabel 1.2 Analisa SDM

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Plan	a. Permasalahan • kebutuhan SDM tidak sesuai standar, namun tidak semua staff memiliki keterangan kompetensi khusus • Belum ada sistem pemantauan rutin kompetensi dan legalitas staff. b. Tujuan • Memastikan 100% staff memiliki kompetensi sesuai tugas • Menjaga keseuaian ketenagaan sesuai standar c. Rencana tindak lanjut • Mengikutsertakan staff yang belum memiliki kompetensi pada pelatihan internal/eksternal.
2. DO	• Mengikut sertakan staff yang belum memiliki kompetensi pada pelatihan internal/eksternal. • Sosialisasi kepada staff terkait pentingnya legalitas dan kompetensi
3. STUDY	• Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi: • Presentase staff dengan kompetensi sesuai tugas • Evaluasi hambatan : • Keterbatasan jadwal pelatihan • Mengumpulkan umpan balik dari staff dan pimpinan unit.
4. ACTION	• Menetapkan monitoring SIP dan kompetensi sebagai kegiatan rutin (triwulan/tahunan) • Memasukan pelatihan kompetensi kedalam rencana kerja unit. • Menyempurnakan SOP pengelolaan SDM unit



1.2 Orientasi

Tabel 1.3 Jumlah Staf Orientasi di Unit

No	Kegiatan Pokok	Hasil	Ket.
1	Orientasi	Tidak ada radiografer yang sedang orientasi	Tetap siapkan modul & evaluasi jika sewaktu-waktu ada staf baru dari pengajuan No. 1.

1.3 Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 1.4 Pendidikan dan pelatihan

No	Kegiatan Pokok	Hasil	Ket.
1	Pendidikan	-	-
2	Pelatihan	-	-

1.4 Evaluasi Kinerja Staf

1.4.1 Kehadiran

Tabel 1.5 Jumlah kehadiran staf

NO	NAMA	CUTI	IZIN/SAKIT	KEHADIRAN
1	Dinda Ayu Puspta, Amd.Rad	2	0	25
2	Isma Mufida, Amd.Rad	1	0	26
3	Erwin Prastyo, Amd.Rad	2	0	25
4	Fahmi Shohibul, Amd.Rad	1	0	26
5	Muhammad Iqbal Maulana, Amd.Rad	1	0	26
6	Renaldi Salsabila, Amd.Rad	2	0	25

1.4.2 Keterlambatan staf

Tabel 1.6 Jumlah keterlambatan staf

NO	NAMA	JUMLAH KETERLAMBATAN
1	Dinda Ayu Puspta, Amd.Rad	0
2	Isma Mufida, Amd.Rad	0
3	Erwin Prastyo, Amd.Rad	0
4	Fahmi Shohibul, Amd.Rad	0
5	Muhammad Iqbal Maulana, Amd.Rad	0
6	Renaldi Salsabila, Amd.Rad	0



1.4.3 Evaluasi Kinerja Staf

Tabel 1.7 Evaluasi Kinerja Staf

NO	NAMA STAF	HASIL EVALUASI KINERJA		
		MEI	JUNI	JULI
1.	Isma Mufida, Amd.Rad	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	BAIK
2.	Erwin Prastyo, Amd.Rad	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3.	Fahmi Shohibul, Amd.Rad	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	BAIK
4.	Muhammad Iqbal Maulana, Amd.Rad	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
5.	Renaldi Salsabila, Amd.Rad	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Tabel 1.7 Tabel Analisa Evaluasi Kinerja Staf

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	☐ Mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja pada bulan Juli bagi staf yang bersangkutan: • Isma Mufida, Amd.Rad: Penurunan pada poin komunikasi efektif kepada pasien dan teman sejawat. • Fahmi Shohibul, Amd.Rad: Penurunan pada poin pengembangan profesi, meliputi kepatuhan pengisian identitas pasien dan pemberian penjelasan pemeriksaan kepada pasien. ☐ Merencanakan program pembinaan, pelatihan internal (<i>re-training</i> SBAR/Effective Communication), penyegaran SOP identifikasi pasien, serta pembuatan <i>checklist</i> edukasi pasien. ☐ Menentukan target perbaikan untuk mengembalikan predikat evaluasi kinerja menjadi "SANGAT BAIK" pada evaluasi bulan berikutnya.
Do	☐ Mengadakan pelatihan/refreshing rutin terkait Komunikasi Efektif (antar staf/sejawat dan kepada pasien). ☐ Mengoptimalkan ketaatan pengisian identitas pasien serta <i>checklist</i> edukasi/penjelasan prosedur pemeriksaan sebelum tindakan radiologi dilakukan. ☐ Melakukan pendampingan dan pemantauan harian (<i>monitoring</i>) secara berkala saat staf melakukan pelayanan.
Study	☐ Mengevaluasi hasil pemantauan bulanan terhadap kepatuhan identifikasi pasien dan efektivitas komunikasi staf. ☐ Menganalisis kemajuan kinerja Isma Mufida dan Fahmi Shohibul setelah dilakukannya pembinaan dan pengawasan. ☐ Membandingkan hasil capaian sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.
Action	☐ Mempertahankan dan memperkuat konsistensi kinerja staf yang sudah mencapai predikat "SANGAT BAIK" (Erwin, Muhammad Iqbal, dan Renaldi). ☐ Melanjutkan pembinaan berkesinambungan bagi Isma Mufida dan Fahmi Shohibul hingga predikat kinerja kembali stabil di tingkat "SANGAT BAIK". ☐ Menjadikan evaluasi ini sebagai acuan standar operasional prosedur (SOP) harian di unit radiologi agar penurunan serupa tidak terulang.



1.4.3 Kualifikasi SDM

Tabel 1.8 Lampiran kualifikasi SDM

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	AC LS	PPI	Penanggulangan Bencana	Code Blue	Komunikasi Efektif	
Ka Inst	dr Agung Setiawan, Sp. Rad (K)	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis (Konsultan)	+	+	+	+	+	+	
Penanggung Jawab	dr Agung Setiawan, Sp. Rad (K)	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	+	+	+	+	+	+	
Dokter Spesialis	dr Rumbiyo Yudho, Sp. Rad	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	+	+	+	+	+	+	
Kepala Ruang	Dinda Ayu Puspita, Amd. Rad	D3	D3	+	-	+	+	+	+	
Pelaksana	Isma Mufida, Amd. Rad	D3	D3	+	-	+	+	+	+	
Pelaksana	Erwin Prasetyo Aji, Amd. Rad	D3	D3	+	-	+	+	+	+	
Pelaksana	Fahmi Shohibul Mubarak, Amd. Rad	D3	D3	+	-	+	+	+	+	
Pelaksana	Iqbal Maulana Amd. Rad	D3	D3	+	-	+	+	+	+	
Pelaksana	Renaldi Salsabila, Amd.Rad	D3	D3	-	-	-	-	-	-	

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tabel 2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Progres Pengembangan Pelayanan	Ket.
1	Penambahan jaringan DICOM pada pemeriksaan CT-Scan	Sudah berjalan di semua SIMRS.	Kekurangan hasil masih belum bisa di buka oleh pasien jika sinyal kurang stabil
2.	Penambahan pelayanan Panoramic	Sudah dilakukan pengajuan bulan Desember 2025	Belum ada persetujuan dari PT.

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

3.1 Lampiran Kinerja Produktivitas

Tabel 3.1 Kinerja Produktivitas Radiologi Berdasarkan Penjamin

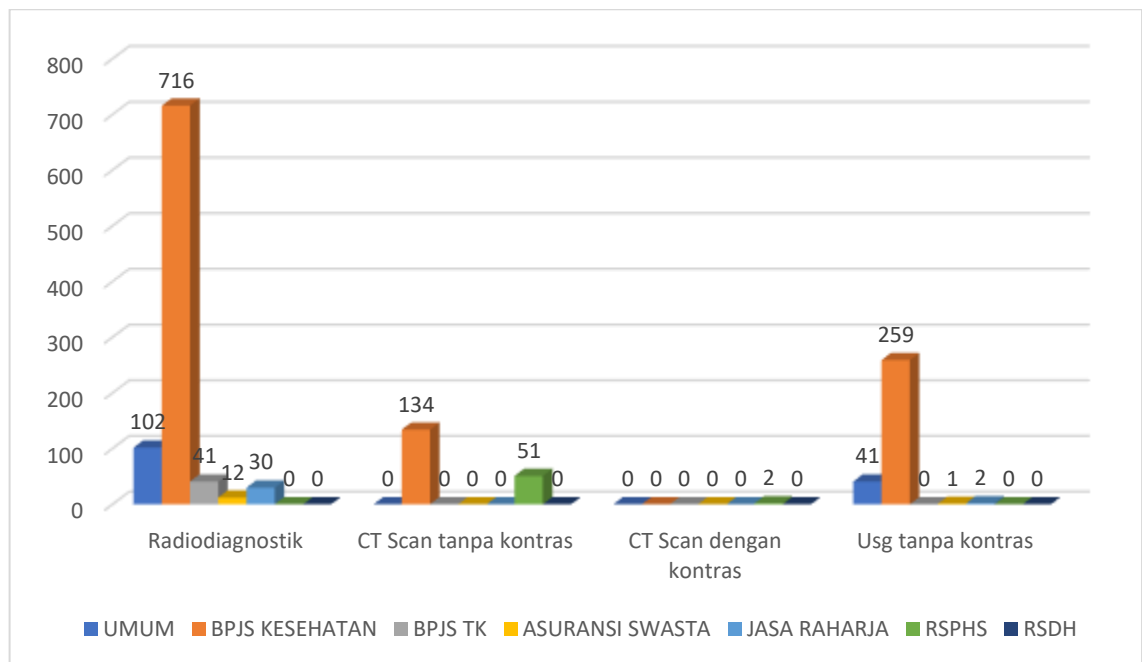


NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			MEI	JUNI	JULI
1.	RADIOLOGI	UMUM	324	217	102
		BPJS KESEHATAN	1105	951	716
		BPJS TK	157	50	41
		ASURANSI SWASTA	10	18	12
		JASA RAHARJA	22	8	30
		RSPHS	0	0	0
		RSDH	0	8	0
		TOTAL	1.074	1.015	901
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	22	28	0
		BPJS KESEHATAN	195	173	134
		BPJS TK	4	8	0
		ASURANSI SWASTA	4	3	0
		JASARA HARJA	6	2	0
		RSPHS	0	0	51
		TOTAL	294	268	185
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	6	5	0
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
		RSPHS	0	0	2
		TOTAL	10	7	2
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	1	3	41
		BPJS KESEHATAN	351	280	259
		BPJS TK	1	0	0
		ASURANSI SWASTA	1	0	1
		JASARAHARJA	0	0	2
		TOTAL	338	304	303



Grafik Produktivitas Pelayanan Radiologi

Tabel 3.2 Analisa data



Tabel 3.3 Analisa Data

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Radiodiagnostik (Rontgen): Mengalami lonjakan signifikan pada bulan Mei (pasien) dari sebelumnya Juni (pasien), lalu sedikit melandai di bulan Juli (pasien). BPJS Kesehatan mendominasi lebih dari 75% total pasien. 2. CT Scan Tanpa Kontras: Stabil dan cenderung meningkat (Maret: 163, Mei: 231, Juni: 214). Ini merupakan lini produk penunjang canggih dengan volume yang solid. 3. CT Scan Dengan Kontras: Volume sangat rendah (Maret: 2, Mei: 6, Juni: 5). 4. USG Tanpa Kontras: Mengalami penurunan yang signifikan, bulan juni 283 sedangkan bulan mei 304 dan bulan April 338	Plan : ❖ Tujuan (Objective): - Mengidentifikasi penyebab penurunan tindakan USG di bulan Juni dan mengembalikan kapasitas pelayanan ke angka normal (>300 tindakan/bulan) pada bulan berikutnya. - Mengantisipasi lonjakan beban kerja Radiodiagnostik & CT Scan agar waktu tunggu pelayanan (<i>Response Time</i>) tetap sesuai standar mutu akreditasi nasional (STARKES). ❖ Rencana Tindakan (Action Plan): - Melakukan audit internal komprehensif terkait ketersediaan dokter spesialis radiologi (jadwal pemeriksaan), kondisi fisik alat USG, serta ketersediaan <i>jelly</i> dan BMHP penunjang lainnya. - Membuat pemetaan jadwal kerja staf (<i>shift</i>) yang lebih fleksibel pada jam-jam puncak kunjungan pasien BPJS Kesehatan guna mengatasi kelelahan



	staf (<i>burnout</i>) akibat lonjakan volume radiodiagnostik. ❖ Indikator Keberhasilan: Alat USG beroperasi 100%, nihilnya 8issal88 waktu tunggu di area rontgen, serta kestabilan pasokan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Do : ❖ Investigasi Fasilitas & Logistik: • Memeriksa <i>logbook</i> pemeliharaan alat (<i>maintenance log</i>) USG pada bulan Juni untuk melihat apakah ada masa operasional yang terhenti (<i>downtime</i>) akibat kerusakan teknis. • Melakukan pengecekan silang (<i>cross-check</i>) ke bagian 8issal88 farmasi mengenai rantai pasok film rontgen dan zat kontras untuk CT Scan guna memastikan tidak ada penundaan akibat stok kosong (<i>stockout</i>). ❖ Manajemen SDM & Alur: • Menerapkan 8issal <i>bridging</i> atau koordinasi alur pendaftaran pasien BPJS 8issal8 tim admisi rawat jalan agar kedatangan pasien tidak menumpuk di satu waktu yang sama. • Mendistribusikan beban kerja tim radiografer secara merata sesuai dengan kapasitas puncak bulanan yang telah terpetakan (khususnya mengacu pada lonjakan bulan Mei-Juni). Study: ❖ Analisis Segmen Penjamin: BPJS Kesehatan adalah penjamin utama di semua lini pemeriksaan (8issal: 951 dari 1.252 pasien Radiodiagnostik di bulan Juni). Ketergantungan yang tinggi ini menuntut proses verifikasi berkas klaim radiologi harus berjalan sangat ketat dan tanpa cacat, demi menghindari risiko klaim menggantung atau <i>pending</i> dari BPJS.
--	---



	❖ Evaluasi CT Scan Kontras: Mengapa angkanya stagnan di bawah 10 pemeriksaan? Perlu dipelajari apakah regulasi internal skrining fungsi ginjal (ureum/kreatinin) pasien yang rumit menjadi hambatan dokter spesialis lain saat akan merujuk pasien ke unit radiologi. Action: • Melanjutkan monitoring bulanan untuk melihat pola peningkatan volume. • Kolaborasi dengan Humas Marketing dalam penawaran MCU • Maintenance dan pengecekan alat secara berkala dan tertib
--	---

3.2 Pembacaan ulang

Dokter Radiologi	Nama Pasien	Bacaan I	Bacaan II
dr. AgungSp.Rad (K)	1. Susiati/241326	Cardiomegali	Tetap cardiomegali, tidak ada efusi
	2. Ahmad haziq	Normal	Bronchopneumonia
dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Dika Ananda/241415	Normal	Fraktura distal
	2. Takim/225016	Cross injury	Crush injury

Analisa :

Untuk bulan Juli 2026 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak sesuai dengan kondisi pasien pada surat permintaan radiologi sehingga dokter radiolog kurang menambahkan hasil bacaan tersebut.

3.3 Respon time dokter

3.3.1 Respon time dr. Agung Setyawan, Sp. Rad (K)

JENIS PEMERIKSAAN	RATA-RATA BULAN MEI		RATA-RATA BULAN JUNI		RATA-RATA BULAN JULI	
	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
RO THORAX	00:03:10	00:45:34 (waktu efektif) 04:32:24 (diatas jam 12 malam)	00:01:50	00:40:34 (waktu efektif) 05:40:25 (diatas jam 12 malam)	00:03:50	00:30:34 (waktu efektif) 04:10:25 (diatas jam 12 malam)
RO VERTEBRAE	-	-	-	-	-	-
RO ABDOMEN	00:08:00	00:28:00(waktu elektif)	-	-	00:06:00	00:04:00 (diatas jam 12 malam)
RO EKSTREMITAS	-	-	-	-	-	-
RO SKULL	-	-	-	-	-	-
USG	00:05:51	00:05:51	00:04:53	00:05:00	00:05:00	00:02:00
CT SCAN NON KONTRAS	00:05:00	01:33:52 (waktu efektif)	00:06:00	00:45:00 (waktu efektif)	00:03:40	00:58:00 (waktu efektif) 9:44:46 (diatas jam 12 malam)



		05:45:00 (diatas jam 12 malam)		11:37:56 (diatas jam 12 malam)		
CT SCAN KONTRAS	-	-	00:12:02	00:45:00 (waktu efektif) 11:37:56 (diatas jam 12 malam)	00:12:02	09:20:10 (diatas jam 12 malam)
RADIOLOGI CITO	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:20:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:10:00 (waktu elektif) 00:30:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:30:00 (diatas jam 12 malam)

3.3.2 Respon time dr. Rumbiyo Yudho, Sp. Rad

JENIS PEMERIKSAAN	RATA-RATA BULAN MEI		RATA-RATA BULAN JUNI		RATA-RATA BULAN JULI	
	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
RO THORAX	00:03:00	0:43:38 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:27:26 (pada saat jam praktek) 10:05:00 (diluar jam praktek)	00:01:40	0:30:26 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
RO VERTEBRAE	00:04:00	0:27:26 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:03:45	0:45:08 (pada saat jam praktek) 11:10:05 (diluar jam praktek)	00:03:45	0:45:08 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)



RO ABDOMEN	00:10:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 13:05:25 (diluar jam praktek)	00:05:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 13:05:25 (diluar jam praktek)	00:05:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
RO EKSTREMITAS	00:02:00	0:28:37 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:26:00 (pada saat jam praktek) 10:05:25 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:26:00 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
RO SKULL	03:00	0:23:30 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	03:00	0:50:00 (pada saat jam praktek) 11:20:15 (diluar jam praktek)	03:00	0:20:00 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
USG	00:05:00	00:06.18	00:05:00	00:08:12	00:05:00	00:01:18
CT SCAN NON KONTRAS	-	-	-	-	-	-
CT SCAN KONTRAS	-	-	-	-	-	-
RADIOLOGI CITO	-	0:15:00	-	-	-	-

1) dr. Agung Setyawan, Sp. Rad (K)

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai Waktu Tunggu Operasional dan Pembacaan Hasil Radiologi berdasarkan data terbaru (bulan Mei, Juni, dan Juli):

a) Ringkasan Utama (Executive Summary)

- Kecepatan Selesai Periksa (Tindakan Fisik): Secara umum berjalan sangat cepat (berkisar antara 1 hingga 12 menit). Pembacaan USG dan Radiologi CITO tercatat paling konsisten.
- Pembacaan Waktu Efektif / Elektif: Menunjukkan performa yang sangat responsif, terutama pada layanan USG (1–5 menit) dan Radiologi CITO (4–10 menit). Untuk RO Thorax dan CT Scan, pembacaan jam efektif berada di bawah 1 jam.
- Pembacaan Di Atas Jam 12 Malam: Mengalami variasi tergantung modalitas. Layanan CITO berhasil mempertahankan kecepatan pembacaan di malam hari (20–30 menit), sementara CT Scan memerlukan waktu yang jauh lebih lama (5,5 hingga 11,5 jam).

b) Analisis Detail per Jenis Pemeriksaan

1) RO THORAX

- Selesai Periksa: Relatif stabil di angka 1–3 menit, meski pada bulan Juli ada sedikit kenaikan durasi menjadi 3 menit 50 detik dari sebelumnya 1 menit 50 detik (Juni).
- Waktu Pembacaan:
Waktu Efektif: Terus membaik secara konsisten setiap bulannya, dari 45 menit (Mei) $\rightarrow$ 40 menit (Juni) $\rightarrow$ 30 menit (Juli).
Di Atas Jam 12 Malam: Terkontrol dengan baik di kisaran 4 hingga 5,5 jam.

2) CT SCAN NON KONTRAS

- Selesai Periksa: Sangat efisien, dengan waktu tindakan sekitar 3,5 hingga 6 menit.
- Waktu Pembacaan:
Waktu Efektif: Mengalami peningkatan kecepatan dari bulan Mei (1 jam 33 menit) menjadi sekitar 45–58 menit di bulan Juni dan Juli.
Di Atas Jam 12 Malam: Menjadi perhatian khusus karena memerlukan waktu tunggu yang cukup panjang, dengan puncak di bulan Juni mencapai 11 jam 37 menit dan Juli pada 9 jam 44 menit.

3) CT SCAN KONTRAS

- Catatan Data: Tidak tercatat pada bulan Mei.
- Durasi Tindakan: Membutuhkan waktu 12 menit 2 detik pada bulan Juni dan Juli (rasional karena mencakup proses *skin test*, insersi IV line, dan protokol kontras).
- Waktu Pembacaan: Pada bulan Juni waktu efektif tercatat 45 menit, sedangkan pada bulan Juli tercatat pembacaan di atas jam 12 malam rata-rata membutuhkan waktu 9 jam 20 menit.



4) RADIOLOGI CITO

- Selesai Periksa: Sangat konsisten di angka 10 menit setiap bulannya.
- Waktu Pembacaan: Sangat baik dalam merespons kasus darurat:
Waktu Elektif/Efektif: Berjalan sangat cepat (4–10 menit).
Di Atas Jam 12 Malam: Stabil pada rentang 20 hingga 30 menit, memenuhi standar respon cepat untuk kasus cito.

5) USG & RO ABDOMEN

- USG: Efisiensi pembacaan meningkat signifikan pada bulan Juli hingga mencapai 2 menit, dari sebelumnya 5–6 menit di bulan Mei/Juni.
- RO Abdomen: Data pemeriksaan hanya tercatat pada Mei (8 menit) dan Juli (6 menit). Pembacaan di atas jam 12 malam pada bulan Juli tercatat sangat cepat yaitu 4 menit.

c) Catatan & Rekomendasi Operations

1) Optimasi Pembacaan CT Scan Malam Hari:

- Waktu tunggu pembacaan CT Scan (Non Kontras & Kontras) di atas jam 12 malam mencapai 9–11 jam. Jika pemeriksaan malam hari tergolong mendesak, disarankan untuk mengevaluasi alur *teleradiology* atau jadwal *on-call* dokter spesialis radiologi.

2) Keberhasilan Penanganan CITO:

- Penanganan Radiologi CITO perlu dipertahankan karena waktu tanggap pembacaan (baik elektif maupun malam hari) berada di tingkat yang sangat responsif (kurang dari 30 menit).

3) Pencatatan Data Kosong:

- Perlu dipastikan kembali apakah pemeriksaan Rontgen spesifik (Vertebrae, Ekstremitas, Skull) memang tidak ada pasien atau terdapat kendala pencatatan/sistem SIMRS.

2) dr Rumbiyo Yudho, Sp. Rad

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai Waktu Tunggu Operasional dan Pembacaan Hasil Radiologi (bulan Mei, Juni, dan Juli):

a) Ringkasan Utama (Executive Summary)

- Proses Pemeriksaan Fisik (*Selesai Periksa*): Berjalan sangat cepat, efisien, dan cenderung membaik dari Mei ke Juli (rata-rata di bawah 5 menit per tindakan).
- Pembacaan Hasil Saat Jam Praktek: Relatif responsif. Pembacaan Rontgen berkisar antara 20–50 menit, sedangkan USG sangat cepat (1–8 menit).
- Pembacaan Hasil Di Luar Jam Praktek: Mengalami perbaikan yang signifikan dari bulan Mei (24 jam) ke bulan Juni dan Juli (~10–12,5 jam).

b) Waktu Pembacaan Hasil (*Turnaround Time* Dokter Spesialis Radiologi)

1) Pada Saat Jam Praktek



- Paling Cepat: USG mencatatkan waktu tanggap tercepat, dengan puncaknya pada bulan Juli yang hanya membutuhkan waktu 1 menit 18 detik.
 - Pemeriksaan Rontgen: Secara umum berjalan lancar:
 - RO Skull: Mengalami penurunan waktu tunggu drastis dari 50 menit (Juni) menjadi 20 menit (Juli).
 - RO Thorax & Ekstremitas: Stabil di kisaran 26–30 menit pada bulan Juli.
 - RO Vertebrae: Masih membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan Rontgen lainnya, yaitu 45 menit 8 detik (Juni & Juli).
- 2) Di Luar Jam Praktek
- Kemajuan Signifikan: Pada bulan Mei, waktu tunggu di luar jam praktek mencapai batas maksimal 24 jam hampir di seluruh pemeriksaan Rontgen. Namun pada bulan Juni dan Juli, angka ini berhasil ditekan menjadi 10 hingga 12,7 jam.
 - Pola Konsisten di Bulan Juli: Semua jenis Rontgen di luar jam praktek pada bulan Juli menunjukkan angka yang identik yaitu 12:42:00 (12 jam 42 menit). Ini mengindikasikan adanya alur *batching* (pembacaan serentak oleh Dokter Radiologi pada jam operasional hari berikutnya) atau *cut-off time* otomatis dari sistem.
- c) Rekomendasi & Tindakan Lanjut
- i) Evaluasi Penulisan/Pencatatan Data:
 - Perlu dipastikan apakah layanan CT Scan dan CITO memang tidak berjalan/tidak ada pasien, atau terdapat kendala *input* data oleh petugas.
 - ii) Standardisasi Pembacaan CITO:
 - Waktu pembacaan CITO di bulan Mei sudah sangat baik (15 menit). Perlu dipertahankan serta diaktifkan kembali pemantauannya untuk bulan-bulan berikutnya.
 - iii) Pengelolaan Layanan Di Luar Jam Praktek:
 - Waktu tunggu pembacaan di luar jam praktek yang berkisar 12 jam sudah jauh lebih baik daripada bulan Mei (24 jam). Namun, untuk kasus-kasus mendesak di luar jam kerja, perlu dipertimbangkan skema *on-call* atau integrasi *teleradiology* agar pembacaan bisa lebih dipercepat.

3.4 Evaluasi pelayanan radiologi regular

Bulan	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pasien	Standar ekspertise	Capaian ekspertise waktu (%)	Status Mutu	Temuan
Mei	Rontgen	940	Kurang dari 3 jam	(213 pasien) 77,3%	Belum Tercapai	Pengisian lembar monitoring suhu ruang baca dokter patuh.



	USG	323	Selesai Hari Yang Sama	100%	Tercapai	Volume pasien USG poli bedah dan poli dalam sangat tinggi.
	CT-Scan	190	1x24 jam	100%	Tercapai	Proses skrining kreatinin pra- kontras memakan waktu antre.
Juni	Rontgen	965	Kurang dari 3 jam	(205 pasien) 78,7%	Tercapai	Hasil expertise lebih dari 3 jam, sudah menurun di bulan ini, di karenakan system PACS rontgen sudah berjalan.
	USG	283	Selesai Hari Yang Sama	100%	Tercapai	Penambahan system PACS
	CT-Scan	176	1x24 jam	100%	Tercapai	Penambahan system PACS
Juli	Rontgen	901	Kurang dari 3 jam	(197 pasien) 78,1%	Belum tercapai	"Terdapat hasil foto yang belum terunggah ke sistem DICOM karena sebagian petugas belum patuh terhadap



						prosedur DICOM."
	USG	303	Selesai Hari Yang Sama	100%	Tercapai	Terdapat perbedaan yang signifikan pada volume pemeriksaan USG pasien antara dr. Yudho dan dr. Agung.
	CT-Scan	187	1x24 jam	100%	Tercapai	"Terdapat hasil scan yang belum terunggah ke sistem DICOM karena sebagian petugas belum patuh terhadap prosedur DICOM."

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	☐ Rontgen Tepat Waktu Belum Capai Target: Capaian ekspertise Rontgen kurang dari 3 jam baru mencapai 78,1% di bulan Juli (197 pasien terlambat) dari target rumah sakit. ☐ Kepatuhan Alur DICOM/PACS: Adanya hasil foto Rontgen dan CT-Scan yang belum terunggah akibat ketidakpatuhan sebagian petugas terhadap prosedur DICOM. ☐ Ketimpangan Beban Kerja USG: Adanya perbedaan volume pasien USG yang signifikan antara dr. Yudho dan dr. Agung. ☐ Waktu Tunggu Pembacaan Malam Hari: Pembacaan CT-Scan (Non Kontras & Kontras) di atas jam 12 malam tergolong lama (berkisar 9 hingga 11 jam).
Do	☐ Sosialisasi SOP DICOM & Re-edukasi:



	• Mengadakan penyegaran (<i>refreshment</i>) SOP pengunggahan foto ke DICOM/PACS untuk seluruh staf radiografer. • Mengintegrasikan verifikasi unggah foto ke dalam logbook harian petugas. ☐ Restrukturisasi Pendaftaran USG: • Menerapkan pembagian kuota pendaftaran secara otomatis/sistematis di SIMRS untuk pendaftaran USG Poli Bedah dan Poli Dalam. ☐ Penerapan Sistem Notifikasi Ekspertise Malam: • Mengaktifkan sistem notifikasi (<i>alert</i>) WhatsApp/sistem kepada dokter spesialis yang sedang bertugas/on-call ketika ada hasil <i>CT-Scan</i> malam hari yang butuh ekspertise cepat. ☐ Evaluasi Threshold Target Mutu: • Melakukan standardisasi penetapan status mutu (menyelaraskan acuan persentase kelulusan antara bulan Juni dan Juli).
Study	☐ Evaluasi Kepatuhan DICOM: Mengukur persentase hasil Rontgen & CT-Scan yang gagal/terlambat terunggah ke DICOM setelah SOP baru diterapkan. ☐ Evaluasi Dampak PACS terhadap Waktu Tunggu: Menghitung apakah penurunan <i>delay</i> unggah DICOM berhasil mendongkrak capaian Rontgen kurang dari 3 jam melewati angka 80%. ☐ Evaluasi Beban Kerja Dokter USG: Membandingkan ulang rekapitulasi jumlah pasien USG dr. Yudho vs dr. Agung setelah pembagian kuota baru. ☐ Evaluasi Turnaround Time Malam Hari: Memantau apakah <i>turnaround time</i> CT-Scan malam hari berkurang signifikan setelah adanya sistem <i>alert/on-call</i>.
Action	☐ Jika Berhasil (Sesuai Target): • Menjadikan <i>Checklist</i> Transfer DICOM sebagai standar operasional tetap (SOP Baku). • Mengunci alokasi kuota otomatis USG pada SIMRS sebagai regulasi internal pendaftaran. ☐ Jika Belum Berhasil: • Kendala DICOM: Mengkaji apakah kendala murni dari faktor manusia (<i>human error</i>) atau ada kendala jaringan/infrastruktur PACS (misal: <i>server drop</i> saat jam sibuk). • Kendala Ekspertise Malam: Mengajukan penambahan dokter spesialis <i>on-call</i> khusus atau bekerja sama dengan penyedia jasa <i>teleradiology</i> pihak ketiga untuk pembacaan malam hari.



3.5 Evaluasi Pelayanan Radiologi CITO

Bulan	Jenis Pemeriksaan Cito	Jumlah Pasien Cito	Target Response Time	Capaian Tepat Waktu (≤ 30 menit)	Status
Mei	Rontgen Cito	6	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
	USG Cito	1	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
	CT-Scan Cito	2	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
Juni	Rontgen Cito	8	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
	USG Cito	1	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
	CT-Scan Cito	3	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
Juli	Rontgen Cito	5	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
	USG Cito	2	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai
	CT-Scan Cito	1	Kurang dari 30 menit	100%	Tercapai

o Analisa Radiologi Cito:

1. Kendala pencatatan hasil cito tidak secara real time di jam terdapat banyak pasien.
2. Keterbatasan Keberadaan Dokter Spesialis Radiologi di Tempat (USG Cito): Pemeriksaan USG bersifat operator-dependent (harus dikerjakan langsung oleh Dokter Spesialis Radiologi). Keterlambatan terjadi pada shift sore/malam atau saat dokter sedang melakukan ekspertise sit-in di ruangan lain, sehingga pasien IGD harus mengantre.

o Tindak Lanjut:

1. Supervisi kepada petugas radiologi agar patu dalam pencatatan hasil cito.
2. Pengaturan ulang jadwal on-call Dokter Spesialis Radiologi agar respons kedatangan ke RS saat dipanggil cito ≤ 30 menit.

3.6 Evaluasi pelayanan radiologi rujukan

Jenis Pemeriksaan	Jam Selesai Periksa	Jam Selesai Hasil	RS Rujukan	Jumlah Pasien
CT-Scan Non Kontras	00:10:00	11:53:08	RSUD LAWANG	47
CT-Scan	00:08:00	01:25:00	RSAU	2



dengan Anastesi			MUNIR	
CT Scan Kontras	00:12:10	21:04:00	RSUD LAWANG	1

a. Analisa Pelayanan Rujukan:

- 1) Selama tahun 2026, terdapat 48 pasien rujuk CT-Scan ke RSUD Lawang , 2 pasien rujuk ct-scan ke RSAU Munir
- 2) Seluruh dokumen hasil rujukan kembali ke RS dalam keadaan utuh, terbaca jelas, dan tepat waktu sesuai PKS.
- 3) Hasil expertise dokter tidak ada yang melebihi batas waktu 1x24 jam.

b. Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan evaluasi tahunan terhadap masa berlaku dokumen PKS dengan faskes rujukan pihak ketiga agar legalitas tetap terjaga.

IV. FASILITAS KESEHATAN (MFK & K3)

4.1 Data Alat Radiologi

Tabel 4.1 Data Alat Radiologi

NO	NAMA ALAT	MERЕК	TYPE	KONDISI	TGL KALIBRASI
1.	C-ARM	SIEMENS	CIOS SELECT	Baik	03/09/2026
2.	D-AR X Ray Kaset			Baik	
3.	D-AR X Ray Kaset			Baik	
4.	Injector	Optione	LF	Baik	
6.	Satu Set DRTech			Baik	
7.	USG	GE / MINDRAY	Versana Essensial / Consona N8 Exp	Baik	04/09/2026
8.	X Ray Mobile	ECOTRON	DF183	Rusak	
10.	X-Ray Conventional	TOSHIBA	E7239	Baik	08/09/2026
11.	CT Scan 64 slices	PHILIPS		Baik	02/09/2026
12.	AC 1 (USG)			Baik	
13.	AC 1 (X-Ray)			Baik	
14.	AC 3 (CT Scan)			Baik	
16.	Drypix			Baik	
17.	Komputer 1 (USG)			Baik	
18.	Komputer 2 (X-Ray)			Baik	
19.	Komputer 3 (CT Scan)			Baik	
20.	Komputer 4 (Panel CT Scan)			Baik	



21.	Laptop (MCU)	LENOVO	Slim 3i (14",8)	Baik	
22.	Printer 1 (USG)			Baik	
23.	Printer 2 (RONTGEN)			Baik	

4.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tabel 4.2 Data Kesehatan dan Keselamatan Staf

NO	INDIKATOR KEJADIAN	JUMLAH		
		MEI'26	JUNI'26	JULI'26
1	Ketidakhadiran	-	-	-
	a. Cuti melahirkan	-	-	-
	b. Penggabungan Libur	1	1	-
	c. Ijin Sakit	-	-	-
	d. Staf mengalami kecelakaan kerja dan PAK	-	-	-
	e. Staf dirumahkan	-	-	-
	f. Staf terpapar pajanan	-	-	-
2	Medical Check Up (MCU)	-	-	-
3	PMT	5 pcs /hari(Senin- Kamis)	5 pcs /hari(Senin- Kamis)	5 pcs /hari(Senin- Kamis)
4	Imunisasi	-	-	-
5	Konseling	-	-	-

4.3 Penambahan alat baru

No.	Nama Alat (Merk dan Tipe)	Kondisi (Secara Rinci)	Rencana Penambahan Alat (Merk dan Tipe)	Jumlah	Ket.		No. Seri
					Proses	Realisasi	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-



4.4 Perbaikan Alat Rusak

No.	Nama Alat Lama (Merk dan Tipe)	Alasan Penggantian/Perbaikan	Tgl. Pengajuan/Perbaikan	Nama Alat Baru (Merk dan Tipe)	Tgl. Penggantian/Perbaikan
	- Signal and Power Brush	- Gantry eror	- 07/07/2026	- Signal and Power Brush	- 25/07/2026
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

4.5 Pemeliharaan alat

4.5.1 PMI

a. Link maintenance alat radiologi

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10xMXfuaOMY3j3PiSZf17AYsYVD72JsrbTS-5oRGzYjM/edit?gid=138246867#gid=138246867> PMI USG

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXyPiddhOiqlKi9K5G7EHIMfdq7t6eRmzswkZR6tAXs/edit?gid=465730098#gid=465730098> PMI RONTGEN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ovUuSwJGIRICnoCjYZXdfd_6E5QcsFXjJBda0Fbyw/edit?gid=895764249#gid=895764249 PMI USG

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ovUuSwJGIRICnoCjYZXdfd_6E5QcsFXjJBda0Fbyw/edit?gid=895764249#gid=895764249 PMI USG

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ovUuSwJGIRICnoCjYZXdfd_6E5QcsFXjJBda0Fbyw/edit?gid=895764249#gid=895764249 PMI USG

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ovUuSwJGIRICnoCjYZXdfd_6E5QcsFXjJBda0Fbyw/edit?gid=895764249#gid=895764249 PMI USG

b. Hasil pengukuran TLD (Pengambilan data 3 bulan sekali)



LAPORAN EVALUASI DOSIS PERSONIL SERTIFIKAT DOSIS RADIASI						
Nomor: E-00902TLD/PPDP/G2/IV/2026						
Nama Instansi: PT. Disa Prima Medika Alamat Instansi: RS. Prima Husada Malang Perum Banjararum Selatan No. 3-7, RT. 003 RW.012, Desa Banjararum, Mondoroko, Kec. Singosari					Tgl. Kirim: 22 April 2026 Tgl. Terima: 22 April 2026 Tgl. Evaluasi: 29 April 2026	
Periode Pemakaian: Januari 2026 s.d Maret 2026						
No	NPR	Nama Pekerja	No. MP / Lencana	Dosis (msv)		
				Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(3)
1	414623	Ayu Bintang Tinara	04072	0.230 (±0.06)	--	--
2	422703	Isma Mufida	00929	0.230 (±0.06)	--	--
3	439327	Fahmi Shohibul Mubarak	05635	0.220 (±0.06)	--	--
4	439326	Dinda Ayu Puspita	05634	0.230 (±0.06)	--	--
5	429698	Erwin Prasetyo Aji	04294	0.230 (±0.06)	--	--
6	434996	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U.	05205	0.440 (±0.11)	--	--
7	421055	dr. Agung Setyawan, Sp.Rad	05753	0.220 (±0.05)	--	--
8	441420	Muhammad Iqbal Maulana	05754	0.220 (±0.05)	--	--
9	436452	Fatimatuz Zahroh, S.Si	06265	0.220 (±0.05)	--	--
Dibuat Oleh: Ruly Herawati, ST					Tanggal: 22 April 2026	
Diperiksa dan disetujui oleh: Ero Wahjuningdiah, S.ST, M.KKK					Tanggal: 11 Mei 2026	
Penerangan:						
1. Tanda minus dua kali (--) = tidak ada data						
2. Nilai Batas Dosis (NBD) pekerja radiasi = 20 msv/th (Perka BAPETEN No. 4 tahun 2013)						
3. Metode Pengujian IEC 62387 tahun 2012						
4. Limit deteksi yang mampu dibaca adalah Limit deteksi TLD = 0.01 mSv						
5. Jika diperoleh nilai lebih rendah dari limit deteksi maka dosis yang diterima adalah 0 msv						
6. Ketidakpastian diukur pada tingkat kepercayaan 95% dan k = 2						
7. Dosis akhir adalah akumulasi dosis pekerja dan dosis TLD kontrol.						
8. TLD ini diuji dengan Metode Kerja MK-PPDP-03 untuk TLD Badge dan MK-PPDP-05 untuk TLD Mata.						
9. Tertelusur dengan TLD Standart tanggal 14 April 2026						
10. Laporan Hasil Evaluasi hanya berlaku untuk TLD yang di uji						

2.5.2 PME

No	Nama Alat (Merk dan Tipe)	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi	PJ	Pihak Ketiga (Kalibrator)
			Mingguan	Bulanan	Tahunan			
1	Rontgen Stationer	-	-	-	√	08/09/2025-08/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
2	Rontgen Portable				√	08/09/2025-08/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
3	CT Scan	-	-	-	√	02/09/2025-02/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
4	USG				√	04/09/2025-04/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica



V. MUTU

5.1 Indikator Mutu

Tabel 5.1 Mutu Nasional

No	Indikator Mutu Nasional	Standar	Capaian
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%
2	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi	100%	100%

Tabel 5.2 Mutu Prioritas

No	Indikator Mutu Prioritas	Kejadian
1	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	7
2	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	32

Analisa :

1. Kepatuhan identifikasi pasien mencapai 100 %. Hal ini disebabkan petugas patuh pada saat indentifikasi pasien.
2. Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi menit sesuai standar 100%.
3. Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien terdapat 7 kejadian
4. Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi terdapat 32 kejadian

5.2 Insiden Keselamatan Pasien

Tabel 5.2 Insiden Keselamatan Pasien

No	Insiden	Jumlah Kejadian		
		Mei'26	Jun'26	Jul'26
1	KPC (Kejadian Potensial Cedera)	0	0	0
2	KNC (Kejadian Nyaris Cedera)	0	0	0
3	KTC (Kejadian Tidak Cedera)	0	1	0
4	Sentinel	0	0	0

Tabel 5.3 Rincian Kejadian

No	Insiden	Masalah yang Terjadi	Staf Terkait
1	KPC (Kejadian Potensial Cedera)	0	0
2	KNC (Kejadian Nyaris Cedera)	0	0
3	KTC (Kejadian Tidak Cedera)	0	0



4	Sentinel	0	0
---	----------	---	---

5.3 Manajemen Risiko (Manrisk)

Tabel 5.3 Rekap Kejadian Keselamatan Kerja

No	Risiko Keselamatan	Upaya Pencegahan	Jumlah Kejadian
1.	Karet pada roda dragbar USG terkelupas	Melakukan pemeliharaan berkala (<i>preventive maintenance</i>), pengecekan fisik roda fasilitas secara rutin setiap bulan, serta pelaporan segera jika ditemukan tanda-tanda aus sebelum karet terkelupas sepenuhnya.	1

Tabel 5. Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	Merencanakan program inspeksi rutin bulanan terhadap seluruh fasilitas <i>mobile</i> (seperti roda dragbar USG dan mesin rontgen <i>mobile</i>) untuk mendeteksi keausan komponen sedini mungkin.
Do	Melaksanakan pengecekan fisik roda dragbar USG secara berkala oleh staf internal unit radiologi dan tim sarana prasarana (IPSRS), serta mencatat kondisinya pada <i>checklist</i> harian/bulanan ruangan.
Study	Mengevaluasi efektivitas pemantauan. Berdasarkan data, jumlah kejadian adalah 0 , yang menunjukkan bahwa kondisi roda saat ini masih terpantau aman dan belum menimbulkan insiden keselamatan kerja ataupun kerusakan alat saat dragbar dipindahkan.
Action	Melanjutkan prosedur pemantauan rutin yang sudah berjalan (<i>status quo</i>), mempertahankan nihil kejadian, serta menjadwalkan peremajaan atau penggantian roda baru secara proaktif jika di kemudian hari ditemukan tanda fisik karet mulai menipis.



VI. PPI

Tabel 6.1 Supervisi PPI

No	Kegiatan	Standar	Capaian		
			Mei'26	Jun'26	Jul'26
1	Edukasi materi PPI (individu)	8	4	3	0
2	Audit Hand Hygiene	100%	90,74%	83,8%	83,8%
3	Audit APD	100%	100%	100%	100%
4	Pemilahan sampah	100%	100%	100%	100%
5	Kebersihan ruangan	100%	100%	100%	100%

Tabel 6.2 Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	- Menyusun jadwal edukasi PPI minimal 2 kali/bulan. - Target peningkatan kepatuhan APD mencapai $\geq 100\%$. - Mempertahankan capaian pemilahan sampah dan kebersihan ruangan. - Menetapkan monitoring rutin supervisi PPI bulanan.
Do	- Melaksanakan edukasi PPI kepada seluruh staf. - Sosialisasi penggunaan APD sesuai standar. - Pemasangan poster hand hygiene & APD di area kerja. - Supervisi langsung oleh tim PPI. - Pengisian checklist audit mingguan.
Study	- Membandingkan capaian tiap bulan terhadap standar: - Hand hygiene meningkat $\rightarrow$ intervensi efektif. - APD belum optimal $\rightarrow$ perlu penguatan kepatuhan. - Edukasi belum berjalan $\rightarrow$ faktor utama gap mutu. - Evaluasi hambatan: - Keterbatasan Waktu, - Jadwal Petugas, - Kurangnya Monitoring Edukasi.
Action	- Menetapkan edukasi PPI sebagai kegiatan wajib terjadwal. - Monitoring kepatuhan APD harian oleh penanggung jawab shift. - Memberikan feedback dan reminder kepada staf. - Mempertahankan praktik baik pada kebersihan ruangan dan pengelolaan limbah.



VII. PKRS

Tabel 3.7.1 Kegiatan PKRS

No	Kegiatan	Target	Capaian		
			Mei'26	Jun'26	Jul'26
1.	Edukasi serta penyuluhan kesehatan pengunjung RS	8	3	0	0

3.8 MONITORING SUPERVISI INSTALASI RADIOLOGI

Tabel 3.8.1 Masalah Yang Terjadi di Unit

No	Temuan	Tindak Lanjut	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi >3 jam Akar masalah: Diluar jam praktek dokter pembacaan foto masih lebih dari 3 jam, terlebih diatas jam 22.00.	P	Menurunkan angka response time pelayanan radiologi >3 jam menjadi ≤3 jam pada hasil pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik dokter radiologi.
		D	Melakukan sosialisasi kepada dokter spesialis radiologi mengenai penggunaan dan akses link PACS yang telah diperbarui, termasuk pemberitahuan otomatis apabila terdapat pemeriksaan yang belum dibaca.
		S	Melakukan monitoring jumlah pemeriksaan dengan response time >3 jam setiap bulan, khususnya pemeriksaan yang selesai setelah pukul 22.00. Mengevaluasi kepatuhan dokter dalam membuka link PACS dan menganalisis penurunan rata-rata waktu pembacaan setelah sosialisasi dilakukan.
		A	Apabila masih ditemukan response time >3 jam, dilakukan evaluasi ulang mekanisme pembacaan di luar jam praktik, penyempurnaan sistem notifikasi PACS, serta penyusunan kebijakan pembacaan on-call/teleradiologi untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari.
2.	DPJP terutama Syaraf belum terbiasa dengan adanya sistem PACS untuk pelayanan CT-Scan dan tetap minta print bagian-bagian hasil CT.edukasi dan sosialisasi	P	Meningkatkan pemanfaatan sistem PACS oleh DPJP dalam melihat hasil CT-Scan serta mengurangi permintaan print film/gambar CT dengan melakukan edukasi dan sosialisasi
		D	Melakukan sosialisasi kepada DPJP, terutama dokter Spesialis Saraf, terkait akses dan manfaat PACS, memberikan panduan penggunaan, serta mendampingi pengguna saat mengakses hasil CT-Scan melalui sistem.



	penggunaan PACS.	S	Melakukan evaluasi jumlah permintaan print hasil CT-Scan setelah sosialisasi dan mengidentifikasi kendala DPJP dalam penggunaan PACS.
		A	Menetapkan penggunaan PACS sebagai media utama akses hasil CT-Scan, melakukan refresh sosialisasi secara berkala, serta memberikan dukungan teknis apabila terdapat kendala penggunaan sistem.
3.	Belum optimalnya pemanfaatan sistem RIS-PACS oleh salah satu dokter radiologi, dimana tidak bisa menggunakan sistem secara konsisten sehingga terjadi ketidakseimbangan distribusi beban kerja dan penumpukan pembacaan hasil radiologi pada dokter lainnya.	P	Mengatasi ketidakseimbangan beban kerja dokter radiologi akibat belum optimalnya pemanfaatan RIS-PACS oleh salah satu dokter radiologi serta keterbatasan jumlah dokter radiologi. Menjalankan proses pencarian dokter radiologi tambahan dan menyusun strategi pemerataan beban kerja sementara.
		D	Melakukan evaluasi waktu tunggu hasil ekspertise, jumlah pemeriksaan yang terbagi antar dokter, serta hambatan dalam penerapan RIS-PACS untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
		S	Melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian ekspertise, jumlah pemeriksaan yang dibaca masing-masing dokter, tingkat pemanfaatan RIS-PACS, dan dampak penambahan dokter terhadap penurunan antrean pembacaan.
		A	Melakukan monitoring berkala terhadap kebutuhan SDM radiologi, melanjutkan proses pemenuhan dokter radiologi tambahan, serta menetapkan strategi kerja sementara sampai dokter baru tersedia.



VIII. PENUTUP

Demikian laporan kerja unit Radiologi Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Bulan Juli Tahun 2026 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan di Bidang penunjang Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan kerja ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Mengetahui,
PLT Kepala Bidang
Penunjang Medis,

Ns. Sherly Rosita, S.Kep

Penyusun,
Kepala Unit Radiologi,

**Dinda Ayu Puspita, AMd.
Rad**

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada
Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes